TOME 21 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Oncologie & Cancérologie

Collège National des Enseignants de Cancérologie (CNEC) • 164 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 21 : Oncologie & Cancérologie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 164 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège National des Enseignants de Cancérologie (CNEC).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	164 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 21

Collège National des Enseignants de Cancérologie (CNEC) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 21 • Oncologie & Cancérologie (164 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

• Chapitre 01 : Cancérogénèse, oncogénétique (291)

• Chapitre 02 : Épidémiologie, FR, prévention des cancers (290)

• Chapitre 03 : Diagnostic des cancers (292)

• Chapitre 04 : Traitement des cancers (294)

• Chapitre 05 : Accompagnement du patient cancéreux (295)

• Chapitre 06 : Médecin préleveur de cellules/tissus (293)

• Chapitre 07 : Toxicité chimiothérapie

• Chapitre 01 — Cancérogénèse, oncogénétique (291)

• Cancérogénèse

• Histoire naturelle des cancers

• Cancer re■sulte de la multiplication de cellules qui e■chappent aux me■canismes re■gulant l'home■ostasie tissulaire (prolife■ration, survie et diffe■renciation) et acquie■rent les capacite■s d'envahir les tissus avoisinants (envahissement loco-re■gional) et a■ distance (me■tastases)

• De■veloppement du cancer se de■roule sur une pe■riode de temps qui peut e■tre assez longue (plusieurs anne■es a■ plusieurs dizaines d'anne■es). Cependant, le de■veloppement et l'e■volution clinique sont tre■s variables selon le type de cancer (en fonction de l'organe d'origine, du type histologique et des caracte■ristiques phe■notypiques de la tumeur) : peut e■tre tre■s agressive ou pluto■t indolente

• Étapes de la cancérogénèse

• Carcinogénèse est un processus multi-étapes

• Étapes histologiques de l'évolution d'un cancer d'origine épithéliale (de revêtement ou glandulaire)

• Dissémination des cellules tumorales

• Lésion pré-tumorale et Pathologie pré-existante

• Biologie des cellules cancéreuses

• Caractéristiques des cellules cancéreuses

• Mutations des proto-oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeur permettent aux cellules d'acquérir ces caractéristiques, indispensables pour transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. L'acquisition de ces proprie■te■s est facilite■e par l'instabilite■ ge■ne■tique des cellules tumorales et l'existence d'une inflammation tissulaire

• Principales caractéristiques des cellules cancéreuses, selon la publication d'Hanahan et Weinberg, Cell, 2011 :

• • Auto-suffisance en signaux de prolife■ration (gain de fonction des proto-oncogènes)

• • Insensibilite■ aux signaux inhibant la croissance cellulaire (perte de fonction des gènes suppresseurs de tumeur)

• • Echappement a■ l'apoptose

• • Capacite■ re■plicative illimite■e (immortalisation - implication des télomères et tolomérases)

• • Capacite■ d'induire une ne■oangiogene■se (impliction de VEGF/VEGFR)

• • Proprie■te■s d'invasion tissulaire locale et de formation de me■tastases a■ distance

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Cancérogénèse, oncogénétique (291)

Chapitre 02 : Épidémiologie, FR, prévention des cancers (290)

Chapitre 03 : Diagnostic des cancers (292)

Chapitre 04 : Traitement des cancers (294)

Chapitre 05 : Accompagnement du patient cancéreux (295)

Chapitre 06 : Médecin préleveur de cellules/tissus (293)

Chapitre 07 : Toxicité chimiothérapie

Chapitre 01 — Cancérogénèse, oncogénétique (291)

Cancérogénèse

Histoire naturelle des cancers

Cancer re■sulte de la multiplication de cellules qui e■chappent aux me■canismes re■gulant l'home■ostasie tissulaire (prolife■ration, survie et diffe■renciation) et acquie■rent les capacite■s d'envahir les tissus avoisinants (envahissement loco-re■gional) et a■ distance (me■tastases)

De■veloppement du cancer se de■roule sur une pe■riode de temps qui peut e■tre assez longue (plusieurs anne■es a■ plusieurs dizaines d'anne■es). Cependant, le de■veloppement et l'e■volution clinique sont tre■s variables selon le type de cancer (en fonction de l'organe d'origine, du type histologique et des caracte■ristiques phe■notypiques de la tumeur) : peut e■tre tre■s agressive ou pluto■t indolente

Étapes de la cancérogénèse

Carcinogénèse est un processus multi-étapes

Étapes histologiques de l'évolution d'un cancer d'origine épithéliale (de revêtement ou glandulaire)

Dissémination des cellules tumorales

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Oncologie & Cancérologie

Paramètre 1	Paramètre 2	Paramètre 3
Initiation	Lésion rapide, irréversible et transmissible de l'ADN, (induite par un facteur carcinogène)	- Facteur physique : radiations UV, radiations ionisantes - Facteur chimique : hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux lourds, amines aromatiques ... - Facteur viral : infection par HBV, EBV, HPV ...
Promotion	1. Exposition prolongée, répétée ou continue à une substance qui entretient et stabilise la lésion initiée 2. Aboutit à l'expansion clonale des cellules pré-tumorales	Stimuli mitogènes : cytokines, facteurs de croissance, hormones ...
Progression	Acquisition des capacités de : - Prolifération/survie cellulaire - Perte de la différenciation - Résistance à l'apoptose (mort cellullaire programmée, immortalisation) - Invasion locale et dissémination à distance (formation de métastases)	

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Oncologie & Cancérologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Dysplasie (néoplasie intra-épithéliale)	Caracte■rise■e par des anomalies de la prolife■ration et de la diffe■renciation cellulaire Mise en e■vidence par des anomalies architecturales tissulaires et cytologiques (mitoses, anomalies nucle■aires ...) Secondaire a■ un e■tat inflammatoire chronique (ex. gastrite, reflux gastro-oesophagien), une infection virale (ex. infection a■ papillomavirus), une exposition a■ des substances carcinoge■nes (tabagisme) De■finie par sa se■ve■rite■ : bas grade ou haut grade (parfois trois cate■gories : le■ge■re / mode■re■e / se■ve■re), la dysplasie ou ne■oplasie intra-e■pithe■liale se■ve■re / de haut grade est e■quivalente au carcinome in situ Évolutions possibles : re■gression, stabilite■, e■volution vers un carcinome invasif
Carcinome in situ	Caracte■rise■ par des anomalies de la prolife■ration et de la diffe■renciation cellulaire associe■es a■ des anomalies d'organisation des cellules entre elles, sans franchissement de la membrane basale (= sans stroma, ni vascularisation) Parfois multifocal (cance■rogene■se de champ) Évolutions possibles : re■gression, stabilite■, e■volution vers un carcinome invasif
Carcinome invasif (franchissement MB)	De■fini par le franchissement de la membrane basale et un envahissement du tissu conjonctif sous-jacent Croissance tumorale ne■cessite une ne■oangiogene■se Tumeur comporte un composant stromal (vasculaire, me■senchymateux, immunitaire)

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 21

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 21 • Oncologie & Cancérologie (164 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège National des Enseignants de Cancérologie (CNEC)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (164 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.